

腹壁韧带样纤维瘤的临床特点及治疗

刘春安 徐飞鹏 刘杨桦 林琳 黄永红 黄哲 冼沛中 许庆文 李有柱

【摘要】 目的 总结腹壁韧带样纤维瘤的临床特点及治疗方法。**方法** 回顾性分析广东医学院附属医院 13 年来 34 例腹壁韧带样纤维瘤诊治情况,并参阅相关文献。**结果** 34 例患者均经手术及病理证实为腹壁韧带样纤维瘤,以腹壁肿块为首发症状,特点为浸润性生长,术前诊断考虑该病者 19 例,切除范围 2 cm 以上与 2 cm 以下(包括侵犯周围脏器)的复发率(1/19 vs 6/15)比较差异有统计学意义($P < 0.05$),放疗也能减少术后复发率,复发患者再次手术均能切除或部分切除,无远处广泛转移。**结论** 腹壁韧带样纤维瘤术前诊断有一定难度,确诊主要依靠病理检查,根治性手术切除是主要治疗方法。

【关键词】 腹壁韧带样纤维瘤;临床特点;手术治疗;疗效分析

The clinical features and treatment of desmoid tumor of abdominal wall LIU Chun-an, XU Fei-peng, LIU Yang-hua, LIN Lin, HUANG Yong-hong, HUANG Zhe, XIAN Pei-zhong, XU Qing-wen, LI You-zhu. Department of Gastrointestinal Surgery, the Affiliated Hospital of Guangdong Medical College, Zhanjiang 524001, China

【Abstract】 Objective To summarize the clinical features and treatment of desmoid tumor of abdominal wall. **Methods** Retrospectively analyzed 34 patients with desmoid tumor of abdominal wall in 13 years in our hospital, and refer to the relevant literature. **Results** Thirty - four patients were confirmed by surgery and pathology. Major complaint was abdominal mass. Tumor was characterized with invasive growth. Nineteen patients were diagnosed as the disease before operation. There was significant difference of relapse rate (1/19 vs 6/15) in resection range above 2 cm and below 2 cm ($P < 0.05$). Radiation therapy can reduce the relapse rate. Recurrence patients can be re - resected by surgery, all patients without distant metastasis. **Conclusions** The diagnosis of desmoid tumor of abdominal wall have some degree of difficulty before operation, it rely mainly on pathology. Radical resection is the main treatment.

【Key words】 Desmoid tumor of abdominal wall; Clinical characteristics; Surgical treatment; Efficacy

腹壁韧带样纤维瘤,也称为侵袭性纤维瘤,该病发生率较低,仅占全部肿瘤的 0.03%,占软组织肿瘤的 3%^[1],因此临床医生对该病的认识不够,延误诊断,采用不够规范的治疗措施,影响治疗效果。本文总结我院 1996 年 1 月至 2009 年 12 月期间收治的经手术证实为腹壁韧带样纤维瘤并有详细资料(能进行随访)的患者 34 例,参阅相关文献,探讨该疾病的临床特点及治疗。

1 资料与方法

1.1 一般资料:本组 34 例患者,均为首次就诊该疾病,病程 2 个月~4 年;男 7 例,女 27 例;年龄 27~49 岁,平均(38±6)岁;17 例有剖宫产或顺产史,10 例有腹部其他手术史,余 7 例无法肯定是否有腹部外伤史。

本组 34 例均以腹壁肿块为首发症状就诊,其中 19 例无不适,15 例患处胀感或轻微不适、隐痛;腹壁肿块为实性、质地硬、边界不甚清楚,活动度差,13 例轻压痛;肿瘤部位:上腹壁 11 例,下腹壁 23 例,26 例肿瘤位于手术切口处或边缘;3 例为 2 个肿瘤,余为单发肿瘤;肿瘤大小:最大肿瘤 8 cm×8 cm×6 cm,最小肿瘤 2.0 cm×1.5 cm×1.5 cm;25 例 B 超检查显示腹壁层内有境界不甚清楚低回声肿块。16 例 CT 检查显示低回声或密度偏高均匀一致的实质性肿块。2 例 MRI 检查显示等强度 T₁ 信号,强度不均匀的 T₂ 信号;术前诊断或考虑该病者 19 例,其余诊断腹部包块。23 例术中行快速病理检查,其余术后常规病理检查。

1.2 手术治疗:34 例患者均行手术切除并且均有病理证实。12 例肿瘤较小者,行局部麻醉,其余采用全身麻醉或连续硬膜外麻醉。19 例手术切除范围为距离肿瘤 2 cm 以上正常皮肤、肌肉、肌腱等组织,若肿瘤

侵犯腹膜者,必须切除部分腹膜,局部缺损较大者,用网片行腹壁重建术;8 例因术前、术中未明确诊断或肿瘤太大切除范围 $< 2\text{ cm}$;3 例下腹部肿瘤与耻骨骨膜粘连,肿瘤切除并部分耻骨骨膜切除;1 例侵犯膀胱,行肿瘤切除并膀胱部分切除;1 例肿瘤侵犯髂血管,无法切除,行肿瘤局部切除;2 例肿瘤穿透腹膜侵犯小肠,肿瘤切除并小肠部分切除。

1.3 放射治疗:19 例手术切除范围 2 cm 以上均未行放射治疗,6 例切除范围 $< 2\text{ cm}$,2 例肿瘤切除并部分耻骨骨膜切除、1 例行肿瘤局部切除和 2 例肿瘤切除并小肠部分切除患者(共 11 例)术后 2 周内行放射治疗,其余 4 例患者因各种原因未行进一步治疗。

2 结果

34 例患者通过病历登记的电话进行随访,均无死亡。切除范围 2 cm 以上的 19 例患者中 1 例复发,复发率为 5.3% ($1/19$),复发时间为 6 年。加行放疗的 11 例患者,3 例复发,复发率为 27.3% ($3/11$),复发时间为 4~6 年,2 例再次行手术 1 次,1 例再次行手术 2 次。4 例未行放疗的患者 3 例复发,复发率 75% ($3/4$),复发时间 2~3 年,1 例再次手术 1 次,2 例再次手术 2 次。经统计学分析,切除范围 2 cm 以上与 2 cm 以下(包括侵犯周围脏器)的复发率比较差异有统计学意义。复发患者再次手术均能切除或部分切除,无远处广泛转移。

3 讨论

3.1 临床特点:

3.1.1 2002 年 WHO 在软组织和骨肿瘤的病理学和遗传学分类中将韧带样纤维瘤定义为:发生于深部软组织的克隆性纤维母细胞增生,具有浸润性生长特点,局部易复发,但从不转移的软组织肿瘤,它属于良、恶性之间的中间状态,称之为中间型,实际上包括了交界性和低度恶性的类型^[2]。Leithner 等^[3]报道复发率高达 $20\% \sim 70\%$,本组 34 例患者术后 7 例复发,局部复发率为 20.6% 。经过 1 次或 2 次手术控制病情或治愈,只有局部浸润性生长,未发现远处转移,与文献报道相似。

3.1.2 本病发病原因尚不十分清楚,可能因素为:①手术与创伤导致肌纤维的破坏,局部出血、血肿为肿瘤发生提供条件。本组 34 例患者中腹部手术史 27 例;②与激素平衡失调有关,特别是雌性激素过多,有报道韧带样瘤标本中可检测到雌激素受体及在相关动物实验中发现外源性激素可诱发韧带样瘤。本组病例多发生在生育期的女性;另外还要考虑遗传因素。有人提出凡发现经产的中年妇女腹壁内有生长缓慢的无痛性肿块,就应考虑到本病的可能。

3.1.3 本病多发生切口附近的肌纤维组织内或与筋

膜相连处,以包块为首发症状,生长较快,质地坚韧,界限不清,边缘不规则,B 超检查、CT 检查和 MRI 检查对诊断有一定帮助,但术前很难确诊,往往与其他体表肿物相互混淆,本组患者术前诊断考虑该病 19 例($19/34$)。目前临床上确诊主要靠病理学,李飞和谢荣庆^[4]总结其病理学特点:①大部分细胞有成纤维细胞的特征,一部分细胞有肌成纤维细胞的特征;②浸润性的生长方式;③在增生的细胞之间有数量不等的胶原存在。④缺少恶性细胞的特征,且很少或没有分裂象。

3.2 治疗:

3.2.1 手术切除是治疗本病的基本手段,术前如高度怀疑腹壁韧带样纤维瘤病,则应对切除的范围、层次以及是否需要行腹壁结构的重建和重建的方式做出充分的估计和设计,切除范围必须距肿瘤 $> 2\text{ cm}$ 。对于侵犯或怀疑侵犯腹膜的应切除腹膜;对已受侵的脏器,能安全切除的应尽量切除。

本组 19 例手术切除范围 $> 2\text{ cm}$ 的患者只有 1 例复发($1/19$),复发的原因尚不清楚,可能仍然与未彻底切除有关,其余 15 例有 6 例复发($6/15$),两组比较具有明显的统计学差异,故作者认为手术彻底切除是惟一的根治方法,该病侵犯周围组织的范围一般 $\leq 2\text{ cm}$,切除范围 $> 2\text{ cm}$ 基本考虑根治,如能真正做到彻底切除,其他综合治疗是没必要的。为做到彻底切除,必须:①早期诊断、早期手术,到后期肿瘤太大将无法彻底切除。②术前或术中病理检查明确诊断能更好指导治疗。③将肿物及其周围半径 2 cm 以上的正常组织(如皮肤、肌肉、肌腱、腹膜)以及受侵犯的腹腔器官一并切除。本组术中只有 23 例行病理检查,说明部分医生对该病的认识不够,仅凭临床经验导致错误诊断,从而导致切除范围不够,增加术后复发率。

3.2.2 放疗作为一种辅助治疗手段尽管不能代替手术,但在抑制肿瘤的浸润性、缩小病灶和预防复发方面起着重要的作用。杨维良等^[5]报道采用⁶⁰Co 放疗来治疗纤维瘤病,利用直线加速器,总量可达 $50 \sim 60\text{ Gy}$,术后常规应用放疗对预防局部复发有一定效果。李洪涛等^[6]报道手术联合放疗可提高韧带样纤维瘤病的无病生存率。本组切除范围 $< 2\text{ cm}$ 加行放疗的 11 例患者中 3 例复发,4 例未行放疗的患者中 3 例复发,故作者也认为放疗能减少术后复发,对于不能彻底切除的患者加行放疗是必须的。临床上患者经常考虑经济因素和放疗的不良反应而不愿意接受放疗,本组 4 例患者可能属于这种情况。这就需要临床医生充分认识放疗的重要性并耐心解释。

3.2.3 化疗及内分泌治疗:其作用尚不明确。Picariell 等^[7]报道应用孕酮、睾丸酮及强的松,特别是三苯氧胺有一定作用, 10 mg/次 , 3 次/d 口服,连续应用 $6 \sim$

8个月可使病情稳定,有一定疗效。该病恶性度低,对化疗一般不敏感。因此,药物方面治疗经验仍需进一步的探讨,其他治疗无效时可以试用。

总之,腹壁韧带样纤维瘤病的临床表现无明显特异性,诊断有一定难度,确诊主要依靠病理检查,治疗是以手术为主的综合治疗。

参考文献

- [1] Amiot A, Dokmak S, Sauvanet A, et al. Sporadic desmoid tumor. An exceptional cause of cystic pancreatic lesion[J]. J Pancreas (Online), 2008, 9(3):339-345.
- [2] 徐光炜,沈镇宙,唐威本. 淋巴瘤,白血病及软组织肿瘤[M]. 北京:人民卫生出版社,2005:109-110.
- [3] Leithner A, Gapp M, Leithner K, et al. Margins in extra - abdominal desmoid tumors; a comparative analysis[J]. J Surg Oncol, 2004, 86(3):152-156.
- [4] 李飞,谢荣庆. 腹壁纤维瘤病临床病理分析[J]. 中国医药导报, 2009, 6(31):62-63.
- [5] 杨维良,张好刚,张东伟,等. 86例腹壁硬纤维瘤的临床分析[J]. 中华普通外科杂志, 2007, 22(10):736-738.
- [6] 李洪涛,戴丹菁,周遵艳,等. 韧带样型纤维瘤病手术联合放疗疗效观察[J]. 现代肿瘤医学, 2010, 18(8):1634-1636.
- [7] Picariello L, Carbonell Sala S, Martinetti V, et al. A comparison of methods for the analysis of low abundance proteins in desmoid tumor cells[J]. Anal Biochem, 2006, 354(2):205-212.

(收稿日期:2011-02-07)

(本文编辑:杨帆)

心包置管引流时间对肺癌心包转移疗效的影响

都彩菊 刘效波 李献兵

【摘要】 目的 探讨不同心包内置管引流时间对肺癌伴恶性心包积液心包填塞的临床疗效和安全性。**方法** 将入选的88例患者随机分为A、B两组。A组44例,为长时间置管组,置管时间为>4周;B组44例,为短期置管组,置管时间<4周。两组患者均接受相同的心包注射和全身静脉注射药物治疗方案,分别观察6个月内的疗效、生存时间、复发率、生存率及置管并发症发生率。**结果** A、B两组近期完全缓解率(54.55% vs 36.36%, $\chi^2=2.93$, $P=0.09$)和部分缓解率(36.36% vs 34.91%, $\chi^2=0.90$, $P=0.87$)差异均无统计学意义,但总有效率比较差异有统计学意义(90.91% vs 70.45%, $\chi^2=5.91$, $P=0.02$), OR=4.19, 95% CI:1.24~14.13。半年内的复发率A、B两组分别为20.45%和38.63% ($\chi^2=3.91$, $P=0.04$)。A、B两组中位生存时间分别为7.96、3.52个月,生存率分别为72.47%和51.38% (Log rank=4.76, $P=0.04$)。两组患者穿刺部位化脓感染发生率分别为4.55%和2.77% ($\chi^2=0.34$, $P>0.05$)。两组患者均未发现心包化脓感染、窦道形成及严重粘连等并发症。**结论** 适当延长心包置管引流时间,可提高治疗效果,安全性高,可作为肺癌心包积液的首要治疗方法。

【关键词】 心包置管引流;肺癌;恶性心包积液

Effect of different duration of pericardial catheter drainage on the outcome of lung cancer patients with malignant pericardial effusion DU Cai-ju*, LIU Xiao-bo, LI Xian-bing. * Department of Cardiothoracic Surgery, the Affiliated Hospital of Weifang Medical College, Weifang 261031, China

【Abstract】 Objective To evaluate the early effects and safety of prolonged implanted catheter in pericardium on the patients with lung cancer and pericardial transmission. **Methods** Eighty-eight cases enrolled were randomly divided into two groups (group A and group B), the period of implanted catheter was more than four weeks in group A and less than four weeks in group B. The treatment protocol of the two groups was the same, then to observe the outcome, survival time of patients, the recurrence rate of pericardial effusion, the complications relevant to the catheter. **Results** The early complete relief rate (CRR) of two groups (A and B) was of no statistical significance ($\chi^2=2.93$, $P=0.09$), but the total effective rate of two groups had a significant statistical difference (90.91% vs 70.45%, $\chi^2=5.91$, $P=0.02$), OR=4.19, 95% CI (confidence interval): 1.24-14.13. The recurrence rate of two groups within half a year was 20.45% vs 38.63%, $\chi^2=3.91$, $P=0.04$, the survival rate of group A and group

B was 72.47% and 51.38% (Log rank=4.76, $P=0.04$). The median survival period of two groups within half a year was 7.96